EBOOK PANDUAN

Panduan Komite PMKP Menyusun Dokumen Mutu Rumah Sakit Sesuai Permenkes 6/2026

Susun program kerja, indikator mutu, dan laporan insiden Komite PMKP sesuai Permenkes 6/2026 dalam satu paket siap pakai.



"Belajar. Praktik. Naik Level."

Diterbitkan oleh **Naik Level Id**
Panduan belajar praktis & aplikatif

BAB 1

Peran dan Tanggung Jawab Komite PMKP di Standar Baru

Banyak Komite PMKP di rumah sakit masih bekerja dengan pola lama: mengumpulkan laporan insiden, sesekali rapat, lalu selesai. Begitu Permenkes 6/2026 mulai disosialisasikan, muncul kebingungan: “Apa yang sebenarnya berubah? Kenapa sekarang kami diminta menyusun program kerja seperti unit kerja lain?” Padahal jawabannya sederhana: **posisi Komite PMKP di standar baru bukan lagi pendukung administratif, melainkan penggerak utama tata kelola mutu dan keselamatan pasien di seluruh rumah sakit.**

Perubahan paling mendasar terletak pada struktur dan garis koordinasi. Pada standar lama, Komite PMKP sering kali “menempel” di bagian mutu atau diketuai oleh salah satu kepala instalasi. Akibatnya, keputusan yang diambil sulit dieksekusi ke unit lain karena tidak punya jalur resmi ke direksi. Di Permenkes 6/2026, Komite PMKP secara eksplisit harus berada langsung di bawah Direktur Rumah Sakit dan sejajar dengan komite medik serta komite keperawatan. Ini bukan sekadar formalitas organisasi: posisi ini memberi kewenangan lintas-unit untuk meminta data, menetapkan indikator, dan mendorong tindak lanjut insiden—tanpa harus “minta tolong” ke bagian lain.

> ⚠️ **Penting: Komite PMKP *bukan* pelaksana teknis semua perbaikan mutu. Tugas utama Anda adalah mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi mutu serta keselamatan pasien. Jika komite ikut mengerjakan perbaikan di lapangan, justru akan kehilangan fungsi pengawasan dan berisiko tidak dipercaya saat meminta akuntabilitas unit kerja.**

Lalu apa saja tanggung jawab inti Komite PMKP dalam standar baru? Minimal ada lima area yang harus Anda kuasai dan jalankan secara konsisten:

1. **Menyusun program kerja tahunan PMKP** yang selaras dengan prioritas mutu rumah sakit dan standar akreditasi.
2. **Menetapkan indikator mutu klinis dan manajerial** yang relevan, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan saat ditelusur surveyor.
3. **Memastikan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP)** berjalan rutin, terdokumentasi, dan dianalisis dengan matriks grading risiko yang benar.
4. **Menyusun laporan evaluasi mutu berkala** ke Direksi dan Komite Mutu RS, lengkap dengan analisis tren dan rekomendasi.
5. **Mendokumentasikan bukti rapat, evaluasi, dan tindak lanjut** agar siap telusur dalam proses akreditasi.

Kalau Anda masih memakai job description lama yang hanya berisi "menerima dan merekap laporan insiden", sekarang saatnya menambahkan lima poin di atas. Jangan menunggu surveyor datang untuk menyadari ada tanggung jawab yang belum dijalankan.

Untuk mulai menyelaraskan peran Komite PMKP dengan standar baru, lakukan langkah praktik berikut:

Langkah 1 — Petakan posisi komite di struktur organisasi mutu RS.
Ambil bagan organisasi rumah sakit terbaru. Pastikan Komite PMKP berada langsung di bawah Direktur, sejajar dengan komite medik dan keperawatan. Jika belum, ajukan revisi SK dan struktur ke bagian organisasi. Ini bukan pekerjaan administratif sepele, karena garis koordinasi akan menentukan seberapa kuat komite Anda bisa meminta data dan mendorong perbaikan.

Langkah 2 — Cocokkan tanggung jawab lama dengan 5 area inti di atas.
Buat tabel sederhana dua kolom: kolom kiri berisi job description komite yang lama, kolom kanan berisi 5 area tanggung jawab standar baru. Lingkari atau tandai area yang belum tertulis di dokumen lama. Dari sana, susun draft uraian tugas baru untuk diajukan ke Direktur.

Langkah 3 — Buat kalender kerja tahunan minimal.
Tanpa kalender, program kerja hanya akan menjadi dokumen mati. Tetapkan minimal: rapat rutin bulanan, evaluasi indikator mutu triwulan, rekapitulasi dan analisis IKP bulanan, serta audit internal atau telusur dokumen setiap enam bulan. Tulis tanggalnya di awal tahun dan sepakati dengan seluruh anggota.

Langkah 4 — Tetapkan jalur koordinasi resmi ke Direksi dan Komite Mutu.
Misalnya: laporan evaluasi mutu dikirim ke Direktur setiap tanggal 10 bulan berikutnya; rapat koordinasi dengan Komite Mutu dilakukan setiap triwulan. Jalur ini penting agar rekomendasi Komite PMKP tidak berhenti di meja rapat.

Langkah 5 — Siapkan bukti dokumen awal.
SK pembentukan komite, struktur organisasi, uraian tugas terbaru, kalender kerja, dan notulen rapat pertama adalah bukti minimum yang harus tersedia. Jangan anggap ini sepele: surveyor hampir selalu meminta dokumen-dokumen tersebut di hari pertama penilaian.

Checklist kesiapan peran Komite PMKP:

Komite PMKP berada langsung di bawah Direktur RS.
Uraian tugas mencakup 5 area: program kerja, indikator mutu, pelaporan IKP, laporan evaluasi, dokumentasi telusur.
Kalender kerja tahunan sudah disusun dan disepakati.
Jalur laporan ke Direksi dan Komite Mutu sudah ditetapkan.
SK, struktur, uraian tugas, dan notulen rapat awal tersedia.

Contoh nyata: RS X sebelumnya menempatkan Komite PMKP di bawah bagian diklat, sehingga setiap kali ada rekomendasi perbaikan insiden, bagian diklat tidak bisa meminta tindak lanjut ke instalasi rawat inap. Setelah standar baru disosialisasikan, direktur merevisi SK dan menempatkan komite langsung di bawahnya. Dalam dua bulan, kepatuhan pelaporan IKP naik dari 40% menjadi 75% karena komite kini punya kewenangan resmi meminta data ke seluruh unit.

Jadi, sebelum sibuk menyusun dokumen dan template, pastikan dulu posisi serta tanggung jawab Komite PMKP sudah jelas dan diakui oleh seluruh unit. Tanpa fondasi ini, program kerja dan indikator mutu yang Anda buat nanti akan sulit dieksekusi.

INTI BAB: Komite PMKP di Permenkes 6/2026 harus berada langsung di bawah Direktur dengan lima tanggung jawab inti: program kerja, indikator mutu, pelaporan IKP, laporan evaluasi, dan dokumentasi telusur. Pastikan posisi organisasi dan uraian tugas sudah disesuaikan sebelum menyusun dokumen teknis.

B A B 2

Menyusun Program Kerja Tahunan Komite PMKP

Banyak Komite PMKP merasa kewalahan saat harus menyusun program kerja tahunan. Padahal, dokumen ini adalah peta jalan yang membuktikan ke surveyor bahwa komite Anda bekerja sistematis, bukan reaktif. Tanpa format baku, kegiatan mutu berjalan sporadis, indikator dipilih asal, dan laporan insiden menumpuk tanpa analisis. Ikuti langkah berikut agar program kerja Anda siap telusur.

1. **Petakan persyaratan standar akreditasi ke dalam kegiatan nyata.** Buka standar PMKP pada Permenkes 6/2026, lalu identifikasi elemen penilaian yang mewajibkan adanya program tahunan, indikator mutu, pelaporan IKP, analisis data, dan tindak lanjut. Jangan menyalin standar mentah-mentah; terjemahkan menjadi kegiatan operasional. Misalnya, standar tentang manajemen risiko insiden diterjemahkan menjadi kegiatan “Sosialisasi dan *refreshment* matriks grading risiko ke seluruh unit kerja.”
2. **Gunakan format program kerja dengan 6 kolom inti.** Setiap baris kegiatan harus memuat: **Tujuan, Kegiatan, Indikator Keberhasilan, Target, Waktu, Penanggung Jawab.** Contoh baris konkret:
    - **Tujuan:** Meningkatkan ketepatan pelaporan IKP.
    - **Kegiatan:** Implementasi form IKP digital dan pelatihan petugas.
    - **Indikator:** Persentase laporan IKP masuk ≤ 24 jam.
    - **Target:** 90% dari total insiden.
    - **Waktu:** Triwulan 1–2.

- **PJ:** Ketua Subkomite Mutu Klinis.

3. **Pilih indikator mutu klinis dan manajerial yang relevan, bukan yang mudah diukur.** Banyak RS memilih indikator karena datanya gampang didapat, padahal tidak menjawab masalah prioritas. Gunakan prinsip SMART (Spesifik, Terukur, Achievable, Relevan, Time-bound). Contoh indikator klinis: kepatuhan *surgical safety checklist*, angka infeksi daerah operasi (IDO) pada bedah bersih, kejadian *medication error*. Contoh indikator manajerial: persentase kelengkapan laporan IKP per unit, waktu respon investigasi insiden grade kuning/merah, persentase tindak lanjut rekomendasi audit internal.

> ⚠️ **Penting: Jangan memilih lebih dari 8–10 indikator prioritas per tahun. Terlalu banyak indikator membuat analisis dangkal dan laporan telat. Fokus pada indikator yang mencerminkan risiko tinggi dan berdampak langsung pada keselamatan pasien.**

4. **Bangun sistem pelaporan IKP yang konsisten dan terdokumentasi.** Siapkan form IKP sederhana (minimal: tanggal, lokasi, kronologi, jenis insiden, grading awal, tindakan segera) dan matriks grading risiko (dampak vs probabilitas) yang sudah disepakati. Pastikan ada alur eskalasi yang jelas: insiden grade kuning/merah wajib dilaporkan ke Komite PMKP dalam 1x24 jam. Untuk menghindari data hilang, gunakan spreadsheet terpusat atau

B A B 3

Memilih dan Merumuskan Indikator Mutu Klinis

Banyak Komite PMKP terjebak memilih indikator mutu klinis secara asal: ikut-ikutan RS lain, menyalin daftar lama, atau memilih yang paling mudah diukur padahal tidak menyentuh masalah utama layanan. Hasilnya, saat ditanya surveyor, “Apa dasar pemilihan indikator ini?” jawabannya sering tidak meyakinkan.

Padahal indikator mutu klinis adalah alat bukti bahwa pelayanan medis di RS Anda aman, efektif, dan terus membaik. Indikator yang baik bukan sekadar angka, tetapi cermin proses klinis yang bisa ditindaklanjuti. Bab ini akan memandu Anda memilih dan merumuskan indikator yang terukur, relevan, dan siap dipertanggungjawabkan.

Kriteria Indikator Mutu Klinis yang Layak Dipakai

Sebelum memilih, pastikan indikator memenuhi lima syarat berikut:

1. **Relevan** – menyentuh area klinis yang berisiko tinggi, bervolume besar, atau sering bermasalah di RS Anda (misalnya infeksi daerah operasi, waktu tanggap IGD, kepatuhan pemberian obat high alert).
2. **Terukur** – punya definisi operasional yang jelas: pembilang (numerator), penyebut (denominator), satuan, dan sumber data.
3. **Valid** – benar-benar mengukur apa yang ingin dinilai, bukan angka perkiraan.
4. **Reliabel** – data dapat dikumpulkan konsisten oleh siapa pun, kapan pun, dengan hasil yang bisa dipercaya.

5. **Dapat ditindaklanjuti** – jika hasilnya jelek, ada intervensi klinis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki.

> **Catatan: Jangan memilih indikator hanya karena datanya sudah tersedia. Mulailah dari masalah klinis prioritas di RS Anda, baru tentukan indikator yang bisa memantaunya.**

Langkah Praktis Merumuskan Indikator

Ikuti lima langkah ini agar indikator Anda siap dipakai dan mudah dijelaskan ke surveyor:

1. **Petakan area klinis prioritas.** Libatkan dokter, perawat, dan bagian mutu. Tanyakan: “Di mana kejadian yang paling sering merugikan pasien?” atau “Proses apa yang paling sering dikeluhkan?” Pilih 3–5 area fokus per tahun, jangan lebih.
2. **Tulis definisi operasional.** Untuk setiap indikator, tetapkan:
    - **Pembilang**: jumlah kejadian/kepatuhan yang diukur.
    - **Penyebut**: total populasi atau total peluang yang seharusnya.
    - **Rumus**: biasanya (pembilang ÷ penyebut) × 100%.
    - **Sumber data**: rekam medis, formulir observasi, sistem informasi RS.
    - **Frekuensi pengukuran**: bulanan, triwulanan.
    - **Target**: angka realistis berdasarkan baseline, bukan asal 100%.
3. **Uji coba pengumpulan data.** Ambil sampel kecil untuk memastikan data benar-benar bisa diambil dan tidak ambigu. Jika petugas bingung membedakan “patuh” dan “tidak patuh”, definisi perlu diperjelas.

4. **Validasi dengan pemangku kepentingan.** Presentasikan indikator ke dokter penanggung jawab pelayanan dan direksi. Pastikan mereka setuju indikator itu penting dan datanya dapat dipercaya.
5. **Dokumentasikan dalam profil indikator.** Buat satu lembar profil per indikator berisi: nama indikator, definisi, rumus, sumber data, target, penanggung jawab, dan rencana tindak lanjut jika target tidak tercapai.

Contoh Nyata: Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

Jangan hanya menulis “kepatuhan identifikasi pasien”. Rumuskan lebih spesifik:

- **Nama indikator**: Persentase kepatuhan identifikasi pasien dengan minimal dua penanda (nama lengkap dan tanggal lahir) sebelum pemberian obat, transfusi, atau tindakan.
- **Pembilang**: jumlah tindakan yang dilakukan dengan identifikasi benar sesuai SOP.
- **Penyebut**: total tindakan yang diobservasi dalam periode tersebut.
- **Sumber data**: observasi langsung oleh perawat PMKP menggunakan checklist, dicatat harian.
- **Target**: ≥ 95% setiap bulan.
- **Penanggung jawab**: Kepala Bidang Keperawatan.

Tips: Batasi jumlah indikator klinis maksimal 10–15 untuk RS menengah. Terlalu banyak indikator membuat data tidak terkelola, laporan terlambat, dan tindak lanjut melebar. Fokus pada yang paling berdampak terhadap keselamatan pasien.

Setelah indikator dirumuskan, pastikan ada mekanisme rutin untuk mereview capaian. Indikator tanpa evaluasi berkala hanyalah angka mati. Di bab selanjutnya, Anda akan belajar menyusun matriks grading risiko insiden agar data insiden bisa diolah menjadi prioritas perbaikan.

INTI BAB: Pilih indikator mutu klinis berdasarkan area prioritas layanan yang berisiko tinggi, bukan asal comot. Rumuskan dengan definisi operasional lengkap—pembilang, penyebut, sumber data, target—agar terukur, valid, dan siap dipertanggungjawabkan ke surveyor.

B A B 4

Memilih dan Merumuskan Indikator Mutu Manajerial

Indikator mutu manajerial sering jadi “anak tiri” dibanding indikator klinis. Padahal, justru dari sinilah surveyor menilai apakah Komite PMKP benar-benar menggerakkan perbaikan mutu atau sekadar membuat laporan formalitas. Masalah yang paling sering muncul: indikator dipilih asal-asalan, tidak punya definisi operasional, target dibuat tanpa baseline, dan cara ukurnya tidak konsisten. Akibatnya, saat ditelusur, datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Nah, di bab ini kita akan praktik langsung memilih dan merumuskan indikator mutu manajerial yang benar-benar terukur, relevan, dan siap dipertanggungjawabkan. Jangan khawatir, kita pakai pendekatan langkah demi langkah.

Langkah 1: Tentukan Area Manajerial yang Kritis

Jangan mulai dari daftar panjang. Mulailah dari pertanyaan: “*Proses manajemen apa yang kalau tidak berjalan, pelayanan dan keselamatan pasien ikut terganggu?*”

Contoh area manajerial yang sering jadi prioritas: - Kepatuhan unit kerja melaporkan insiden keselamatan pasien (IKP) - Ketepatan waktu tindak lanjut rekomendasi rapat Komite PMKP - Kelengkapan dokumen program kerja tahunan unit - Persentase rapat mutu yang dihadiri oleh perwakilan manajemen - Waktu respons Komite PMKP terhadap laporan insiden risiko tinggi

Pilih 3–5 indikator per tahun. Terlalu banyak indikator justru membuat tim

kewalahan dan data tidak terurus.

> ⚠️ **Penting: Setiap indikator yang Anda pilih harus bisa dijawab dengan data yang sudah ada di RS atau data yang mudah dikumpulkan. Jangan memilih indikator yang menuntut sistem informasi baru yang mahal. Surveyor lebih menghargai indikator sederhana yang valid daripada indikator canggih yang datanya fiktif.**

Langkah 2: Rumuskan dengan Format SMART

SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Rumusan indikator harus menjawab: apa yang diukur, pada populasi mana, dalam periode kapan.

Contoh rumusan yang **salah**:
"Meningkatkan pelaporan insiden."
Terlalu umum, tidak terukur, tidak ada batas waktu.

Contoh rumusan yang **benar**:
"Persentase unit pelayanan yang melaporkan minimal satu insiden keselamatan pasien per bulan selama triwulan berjalan."

Perhatikan, rumusan ini langsung menjelaskan numerator (unit yang melapor) dan denominator (total unit pelayanan).

> 💡 **Tips: Gunakan kata benda yang bisa dihitung persentase, jumlah, rasio, atau waktu. Hindari kata kerja seperti "meningkatkan", "memperbaiki", "memastikan" sebagai kata utama indikator, karena sulit diverifikasi.**

Langkah 3: Tetapkan Target yang Realistis Berbasis Baseline

Jangan pernah menulis target 100% tanpa tahu kondisi awal. Itu bunuh diri di hadapan surveyor. Ambil data 3–6 bulan terakhir, hitung capaian saat ini, lalu naikkan bertahap 5–10%.

Contoh:
- Baseline kepatuhan pelaporan IKP: 62%
- Target tahun ini: 75%
- Alasan: kenaikan 13% adalah tantangan yang masuk akal dengan intervensi perbaikan.

Jika Anda belum punya baseline, jadikan triwulan pertama sebagai periode baseline, baru tetapkan target untuk triwulan berikutnya. Jangan malu mengakui bahwa baseline belum tersedia; surveyor justru melihat proses berpikir yang jujur.

Langkah 4: Tentukan Cara Ukur (Definisi Operasional)

Ini bagian yang paling sering bolong. Tanpa definisi operasional, dua orang bisa menghitung indikator yang sama dengan hasil berbeda.

Untuk setiap indikator, tetapkan: - **Numerator**: apa yang dihitung sebagai “kasus” atau “kejadian” yang memenuhi kriteria - **Denominator**: total populasi atau peluang yang relevan - **Sumber data**: dari mana angka diambil (form IKP, notulen rapat, logbook, SIM RS) - **Frekuensi pengumpulan**: harian, mingguan, bulanan, atau triwulan - **Penanggung jawab**: satu nama atau satu unit, jangan tim tanpa nama

Contoh praktis untuk indikator *“Persentase tindak lanjut rekomendasi rapat PMKP selesai ≤ 30 hari”*:

- **Numerator**: Jumlah rekomendasi rapat PMKP yang tindak lanjutnya selesai dalam ≤ 30 hari kalender sejak rapat.
- **Denominator**: Total rekomendasi rapat PMKP pada periode yang sama.
- **Sumber data**: Notulen rapat PMKP + form tindak lanjut rekomendasi.
- **Frekuensi**: Bulanan.
- **Penanggung jawab**: Sekretaris Komite PMKP.

Dengan definisi seperti ini, siapa pun yang menghitung akan menghasilkan angka yang sama. Data Anda siap telusur.

Langkah 5: Uji Kelayakan Sebelum Ditetapkan

Sebelum indikator masuk ke program kerja tahunan, lakukan uji cepat berikut bersama tim PMKP:

✅ Checklist uji indikator:

- Apakah indikator ini berkaitan langsung dengan standar akreditasi Permenkes 6/2026 atau prioritas mutu RS?
- Apakah numerator dan denominatornya bisa dihitung dari data yang sudah ada atau mudah dikumpulkan?
- Apakah definisi operasionalnya sudah ditulis dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat?
- Apakah targetnya realistis berdasarkan baseline, bukan asumsi?
- Apakah ada satu penanggung jawab yang jelas untuk mengumpulkan dan melaporkan data?

Jika semua jawaban “ya”, indikator Anda siap dijalankan. Jika ada satu saja “tidak”, perbaiki dulu sebelum masuk dokumen resmi.

Dengan mengikuti lima langkah ini, indikator mutu manajerial Anda bukan

lagi daftar hiasan, melainkan alat ukur nyata yang bisa ditelusuri surveyor dari awal sampai akhir.

INTI BAB: Pilih 3–5 indikator manajerial yang relevan dengan standar dan prioritas RS, rumuskan secara SMART dengan definisi operasional yang jelas, lalu tetapkan target realistis berbasis baseline agar data siap dipertanggungjawabkan.

B A B 5

Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Kalau ada satu hal yang paling sering ditanya surveyor saat telusur PMKP, itu bukan soal tebalnya dokumen, tapi: “Coba tunjukkan alur insiden dari unit sampai Komite PMKP, dan bukti tindak lanjutnya.” Maka sistem pelaporan IKP harus praktis, cepat, dan konsisten. Tujuan utamanya bukan mencari siapa yang salah, tapi mencegah insiden yang sama terulang.

Alur pelaporan 6 langkah dari unit ke Komite PMKP:

1. **Amankan pasien dan barang bukti.** Begitu insiden terjadi, staf wajib menstabilkan pasien dulu. Setelah aman, simpan barang bukti: label obat, selang, alat, atau dokumen terkait. Jangan dibuang atau direkonstruksi sendiri.
2. **Isi form ringkas maksimal 2x24 jam.** Pelapor atau saksi mengisi form IKP versi unit. Kepala unit wajib menandatangani dan mengirimkan ke Komite PMKP. Untuk insiden sentinel atau KTD berat, laporkan langsung via telepon/WA ke Ketua Komite PMKP maksimal 1x24 jam, lalu tetap lengkapi form tertulis.
3. **Registrasi dan notifikasi.** Komite PMKP memberi nomor registrasi insiden, misalnya `IKP/IRNA/03/2027/014`. Kemudian Komite menginformasikan ke unit terkait siapa tim investigasi dan tenggat penyelesaian.
4. **Investigasi dan grading.** Tim investigasi mengumpulkan fakta: wawancara staf, cek dokumen, lihat kondisi ruangan. Hasil investigasi digunakan untuk menentukan jenis insiden (KTD, KNC, KTC, sentinel)

dan grading risiko berdasarkan matriks. Jangan menunda investigasi lebih dari 3x24 jam untuk insiden berat.

5. **Tindak lanjut dan umpan balik.** Komite PMKP mengirim rekomendasi perbaikan ke unit maksimal 7 hari setelah investigasi. Unit melaksanakan perbaikan, lalu melaporkan hasilnya ke Komite. Kalau tidak selesai, Komite membuat eskalasi ke Direksi.
6. **Rekap dan pelaporan berkala.** Komite PMKP merekap semua insiden per bulan: jumlah, jenis, grading, unit terbanyak, dan status tindak lanjut. Data ini dimasukkan ke laporan mutu bulanan/triwulanan ke Direksi dan Komite Mutu.

Form siap pakai unit:

Form IKP ringkas cukup satu halaman, memuat:

- Nomor insiden (diisi Komite)
- Tanggal dan jam kejadian
- Unit/lokasi
- Nama pasien/no. RM
- Jenis insiden: KTD / KNC / KTC / sentinel
- Kronologi singkat (fakta, jangan opini)
- Tindakan segera pada pasien
- Nama pelapor dan saksi
- Tanda tangan kepala unit

Contoh pengisian kronologi yang baik: “Infus NaCl 0,9% milik pasien A di tempat tidur 2 terpasang ke pasien B di tempat tidur 3 saat pergantian shift, terdeteksi 15 menit setelah terpasang.” Contoh yang buruk: “Perawat lalai memeriksa identitas pasien.” Hindari menyalahkan orang di form awal.

💡 **Tips: Buat alur IKP versi visual sederhana—satu halaman flowchart—lalu tempel di nurse station dan ruang staf. Surveyor lebih mudah melihat alur nyata daripada narasi panjang di dokumen mutu.**

⚠️ **Penting: Gunakan matriks grading risiko yang sama di seluruh unit dengan skala dampak: ringan (tidak cedera/cedera ringan), sedang (cedera sedang), berat (cedera berat/cacat), ekstrem (kematian/sentinel). Jangan biarkan kepala unit mengategorikan insiden tanpa panduan; hal ini sering membuat data IKP tidak bisa ditelusuri surveyor.**

Setelah sistem ini berjalan, Komite PMKP tinggal menjaga konsistensi: laporan masuk tepat waktu, investigasi selesai, feedback ke unit terdokumentasi, dan rekap sampai ke Direksi. Kalau empat hal itu ada, telusur surveyor akan jauh lebih tenang.

INTI BAB: Alur IKP yang efektif adalah amankan pasien, lapor maksimal 2x24 jam, investigasi dengan grading risiko yang konsisten, lalu beri umpan balik dan rekap berkala ke Direksi. Form ringkas satu halaman di unit adalah kunci kepatuhan pelaporan.

B A B 6

Matriks Grading Risiko Insiden

Grading risiko insiden bukan sekadar memberi label hijau, kuning, atau merah. Ini adalah langkah awal yang menentukan kecepatan respons, alokasi sumber daya, dan pola tindak lanjut yang diminta oleh Direksi maupun surveyor akreditasi. Sayangnya, banyak Komite PMKP yang masih mengandalkan “feeling” atau kategori seadanya, sehingga insiden serius bisa tertangani lambat, sementara insiden ringan justru menghabiskan energi tim.

Di bab ini, Anda akan belajar menggunakan matriks grading risiko 5×5 yang sederhana namun bisa dipertanggungjawabkan saat ditelusur. Matriks ini menghubungkan dua sumbu: **Dampak/Keparahan (Severity)** dan **Probabilitas/Kemungkinan (Likelihood)**. Perpotongan keduanya menghasilkan skor 1–25 yang kemudian dipetakan menjadi empat level risiko: **Rendah (hijau), Sedang (kuning), Tinggi (oranye), Ekstrem (merah)**.

Matriks ini mengacu pada praktik umum keselamatan pasien dan selaras dengan pendekatan manajemen risiko di standar akreditasi terbaru. Yang terpenting, matriks ini membuat penilaian Anda konsisten dan bisa dijelaskan secara objektif.

Langkah Praktik Menentukan Grading Risiko

Berikut lima langkah konkret yang bisa langsung Anda terapkan saat rapat atau investigasi insiden.

1. Definisikan insiden secara spesifik

Jangan menilai “insiden jatuh” secara umum. Tuliskan kejadian aktual: pasien

lansia terjatuh dari tempat tidur saat malam hari, tidak ada pagar pengaman, dan pasien mengalami memar ringan di lengan. Semakin spesifik deskripsi, semakin akurat penilaian dampak dan probabilitasnya.

2. Tentukan skor Dampak (Severity)

Gunakan skala 1–5: - **1 – Tidak cedera:** tidak ada bahaya fisik atau psikologis. - **2 – Cedera ringan:** memar, lecet, butuh observasi singkat. - **3 – Cedera sedang:** perlu perawatan tambahan, perpanjangan rawat. - **4 – Cedera berat:** cacat permanen, perlu tindakan invasif, transfer ICU. - **5 – Kematian atau kehilangan fungsi utama permanen.**

Contoh: pasien jatuh dengan memar ringan → skor dampak 2.

3. Tentukan skor Probabilitas (Likelihood)

Gunakan skala 1–5 juga: - **1 – Sangat jarang:** belum pernah terjadi dalam 5 tahun. - **2 – Jarang:** pernah terjadi 1–2 kali dalam 5 tahun. - **3 – Mungkin:** terjadi beberapa kali dalam setahun. - **4 – Sering:** terjadi setiap bulan. - **5 – Hampir pasti:** terjadi berulang dalam kondisi yang sama.

Contoh: di unit rawat inap tersebut, insiden jatuh lansia tanpa pagar pengaman sudah terjadi dua kali dalam tiga bulan terakhir → skor probabilitas 4.

4. Hitung skor risiko dan petakan level

Kalikan skor dampak dan probabilitas (atau gunakan matriks visual). Contoh di atas: 2 × 4 = 8.

Interpretasi level risiko: - **1–4 = Rendah (hijau):** tindak lanjut ringan, cukup dokumentasi dan edukasi. - **5–9 = Sedang (kuning):** butuh analisis akar masalah sederhana dan perbaikan lokal dalam 14 hari. - **10–16 = Tinggi (oranye):** wajib investigasi menyeluruh, lapor ke Komite Mutu, dan rencana

perbaikan dalam 7 hari. - **17–25 = Ekstrem (merah):** insiden serius, lapor Direksi dalam 24 jam, lakukan Root Cause Analysis (RCA) penuh, dan tindakan segera cegah berulang.

Pada contoh jatuh tersebut, skor 8 berarti **Sedang**. Tim harus melakukan analisis sederhana, misalnya mencari tahu kenapa pagar pengaman tidak terpasang, dan segera pasang pagar untuk semua tempat tidur lansia dalam 14 hari.

5. Dokumentasikan keputusan grading di form IKP

Catat skor dampak, probabilitas, skor total, dan level risiko beserta alasan singkatnya. Ini penting untuk bukti telusur surveyor. Jangan hanya menulis “risiko sedang” tanpa angka. Surveyor akan menghargai transparansi penilaian Anda.

> ⛔ **Waspada: Jangan menaikkan level risiko hanya karena takut dianggap lalai, atau menurunkan level agar terlihat aman. Kedua praktik ini justru melemahkan sistem keselamatan pasien dan bisa terdeteksi saat survei. Gunakan data dan definisi yang disepakati tim.**

> 💡 **Tips: Buat kartu saku matriks 5×5 berukuran A5 dan letakkan di setiap nurse station atau ruang rapat. Dengan begitu, saat insiden terjadi, petugas bisa langsung melakukan penilaian awal tanpa harus menunggu Komite PMKP.**

Contoh Nyata Lain

Misal insiden: salah obat (pasien menerima obat pasien lain). Dampaknya

pasien mengalami reaksi alergi sedang, butuh antihistamin dan observasi 24 jam → Dampak = 3. Probabilitas kejadian serupa di unit tersebut: pernah 1 kali dalam setahun terakhir, tetapi prosedur identifikasi pasien tidak konsisten → Probabilitas = 3. Skor = 3 × 3 = 9, masuk kategori **Sedang** (batas atas). Jika probabilitas naik menjadi 4 karena sudah sering terjadi, skor 12 menjadi **Tinggi** dan wajib RCA.

Dengan matriks ini, Anda tidak lagi berdebat soal “ini serius atau tidak” tanpa dasar. Semua orang bicara angka yang sama.

INTI BAB: Gunakan matriks grading 5×5 (dampak × probabilitas) untuk menentukan level risiko insiden secara objektif, lalu petakan tindak lanjut sesuai levelnya: rendah, sedang, tinggi, atau ekstrem. Dokumentasikan skor dan alasan di form IKP agar siap ditelusur kapan saja.

B A B 7

Root Cause Analysis (RCA) Sederhana untuk Insiden Berat

RCA sering dianggap rumit dan butuh tenaga ahli. Padahal, dengan pendekatan sistematis, Komite PMKP bisa melakukan investigasi akar masalah sendiri—tanpa konsultan eksternal. Kuncinya: disiplin pada proses, bukan pada kecanggihan *tools*.

Prinsip utama RCA: cari penyebab sistem, bukan menyalahkan orang. Insiden berat hampir selalu melibatkan kombinasi kelemahan prosedur, komunikasi, lingkungan kerja, dan pengawasan. Tugas tim RCA adalah membongkar lapisan-lapisan itu satu per satu.

Langkah praktisnya:

1. **Bentuk tim kecil (3–5 orang).** Libatkan orang yang paling tahu proses terkait insiden: kepala ruangan, dokter/bidan penanggung jawab, perawat pelaksana, dan staf mutu. Hindari melibatkan individu yang sedang dalam tekanan emosional pasca-insiden.
2. **Kumpulkan fakta, bukan opini.** Wawancarai saksi dan pelaku langsung secara terpisah. Catat kronologi 5W+1H (apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana). Gunakan rekam medis, logbook, atau dokumentasi lain sebagai bukti pendukung.
3. **Buat peta kronologi sederhana.** Urutkan kejadian dari awal sampai insiden terjadi. Bisa dalam bentuk tabel dua kolom: waktu dan kejadian. Ini memudahkan melihat celah proses yang terlewat.
4. **Gali akar masalah dengan 5 Whys atau fishbone sederhana.** Untuk

tiap celah kritis, tanyakan “mengapa?” minimal lima kali sampai Anda menemukan akar sistem, bukan sekadar kesalahan individu. Contoh: “Mengapa pasien jatuh? Karena pagar tempat tidur tidak terpasang. Mengapa tidak terpasang? Karena perawat lupa. Mengapa lupa? Karena tidak ada checklist harian pemasangan pagar. Mengapa tidak ada checklist? Karena SOP tidak mewajibkan. Akar: SOP tidak mengatur pemasangan pagar tempat tidur pada pasien risiko jatuh.”

> **Tips: Jika 5 Whys terasa buntu, gunakan fishbone sederhana: gambar tulang ikan dengan enam “tulang” kategori—Manusia, Metode, Mesin, Material, Lingkungan, Manajemen. Letakkan setiap fakta kronologi ke kategori yang sesuai. Akar masalah biasanya muncul di kategori Manajemen atau Metode.**

5. **Identifikasi faktor kontribusi.** Bedakan antara akar masalah utama (penyebab paling dasar) dan faktor kontribusi (hal yang memperparah, tetapi bukan penyebab primer). Contoh: tidak ada SOP adalah akar utama, sedangkan beban kerja tinggi adalah kontribusi.
6. **Susun rencana tindakan korektif dan preventif.** Setiap akar masalah harus menghasilkan minimal satu tindakan. Gunakan format: tindakan spesifik, penanggung jawab, tenggat waktu, dan indikator keberhasilan. Contoh: “Revisi SOP pemasangan pagar tempat tidur, PJ: Kepala Ruangan, tenggat 2 minggu, indikator: SOP disahkan dan disosialisasikan ke semua perawat.”
7. **Verifikasi dan pantau.** Jadwalkan evaluasi 30 hari dan 90 hari setelah tindakan dijalankan. Pastikan tindakan benar-benar menghilangkan atau menurunkan risiko. Jika insiden serupa terulang, tandanya RCA perlu

diulang karena akar masalah belum ditemukan.

Contoh kasus nyata: insiden salah obat dosis tinggi. Tim RCA menemukan akar: label obat mirip dan tidak ada *double-check* independen. Tindakan: stiker peringatan pada obat high-alert, SOP *double-check*, dan edukasi staf. Hasil: tidak ada pengulangan dalam 6 bulan.

✅ Checklist RCA siap telusur:

- ☐ Kronologi insiden terdokumentasi lengkap dengan bukti.
- ☐ Minimal satu teknik analisis (5 Whys atau fishbone) digunakan dan hasilnya tertulis.
- ☐ Akar masalah jelas dan berorientasi sistem, bukan individu.
- ☐ Setiap akar masalah punya tindakan korektif dengan PIC dan tenggat.
- ☐ Evaluasi tindakan terjadwal dan terdokumentasi.

RCA sederhana bukan berarti asal-asalan. Dengan mengikuti langkah di atas, Komite PMKP dapat menghasilkan investigasi yang valid dan siap ditelusuri surveyor—tanpa biaya konsultan.

INTI BAB: RCA insiden berat bisa dilakukan internal dengan langkah terstruktur: kumpulkan fakta, petakan kronologi, gali akar dengan 5 Whys/fishbone, lalu susun tindakan korektif dengan PIC dan tenggat. Dokumentasi yang rapi adalah bukti telusur utama.

B A B 8

Menyusun Laporan Evaluasi Mutu ke Direksi

Masalah klasik di banyak rumah sakit: laporan mutu ke Direksi sering telat, isinya terlalu teknis, atau malah hanya berisi tabel angka tanpa cerita. Akibatnya, manajemen tidak mendapat gambaran jelas tentang kondisi mutu dan keselamatan pasien, dan keputusan strategis jadi tersendat. Padahal, laporan evaluasi mutu adalah alat komunikasi utama Komite PMKP ke pimpinan—bukan sekadar formalitas akreditasi.

Bab ini akan membantu Anda menyusun laporan berkala yang ringkas, visual, dan langsung bisa dipakai Direksi untuk mengambil keputusan. Kuncinya: **template baku yang siap diisi rutin**, bukan laporan dibuat dari nol setiap periode.

Langkah Praktik: Menyusun Laporan Evaluasi Mutu Berkala

1. **Tetapkan frekuensi dan format baku**
   Sepakati dengan Direksi: laporan bulanan atau kuartalan? Buat template tetap dalam satu dokumen (bisa spreadsheet atau word processor) dengan komponen yang sama setiap periode. Contoh: Laporan Bulanan Mutu & Keselamatan Pasien.

2. **Mulai dengan ringkasan eksekutif satu halaman**
   Tulis 3–5 poin utama di halaman pertama: apa yang membaik, apa yang memburuk, apa yang butuh keputusan Direksi. Gunakan kalimat singkat dan langsung. Jangan paksa Direksi membaca seluruh laporan untuk menemukan masalah utama.

3. **Sajikan data indikator mutu dengan grafik tren**

Hindari tabel panjang berisi puluhan baris angka. Gunakan grafik garis atau batang untuk menunjukkan tren 3–6 bulan terakhir, bandingkan dengan target. Beri warna: hijau untuk capai target, merah untuk di bawah target. Ini lebih cepat dipahami daripada deretan angka.

4. **Laporkan insiden keselamatan pasien secara ringkas**
   Tampilkan jumlah insiden per kategori (KTD, KNC, KTC, Kondisi Potensial), grading risiko (rendah, sedang, tinggi, ekstrem), dan status tindak lanjut. Gunakan format tabel kecil atau diagram batang. Pastikan data ini konsisten dengan sistem pelaporan IKP yang sudah dibahas di bab sebelumnya.

5. **Berikan analisis singkat untuk temuan penting**
   Untuk setiap indikator yang tidak capai target atau insiden dengan grading tinggi, tambahkan 1–2 kalimat analisis akar masalah. Contoh: *"Angka kepatuhan cuci tangan turun 15% karena supervisi berkurang selama rotasi perawat baru."* Jangan berhenti di angka.

6. **Tulis rekomendasi tindak lanjut yang spesifik**
   Setiap rekomendasi harus memuat **siapa** penanggung jawab, **apa** tindakannya, dan **kapan** batas waktunya. Contoh: *"Kepala Ruang Rawat Inap melakukan supervisi cuci tangan setiap shift selama 2 minggu, evaluasi pada 15 bulan depan."*

7. **Lampirkan bukti telusur**
   Sertakan notulen rapat Komite PMKP, daftar hadir, dan dokumentasi tindak lanjut (foto, checklist, atau memo). Ini penting untuk kebutuhan telusur surveyor akreditasi.

💡 **Tips: Gunakan warna merah hanya untuk hal yang benar-benar butuh perhatian. Jika semua indikator merah, Direksi akan menganggap laporan tidak kredibel. Tunjukkan juga pencapaian yang baik agar ada keseimbangan.**

⛔ **Waspada: Jangan pernah mengirim laporan tanpa rekomendasi. Laporan yang hanya berisi data tanpa usulan tindak lanjut akan berakhir sebagai tumpukan kertas dan tidak mendorong perbaikan mutu.**

Contoh format laporan bulanan satu halaman:

- **Judul:** Laporan Evaluasi Mutu & Keselamatan Pasien – Juli 2026
- **Ringkasan Eksekutif:** 3 poin utama
- **Capaian Indikator Klinis:** Grafik tren 6 bulan (misal: kepatuhan hand hygiene, angka infeksi, waktu tanggap IGD)
- **Insiden Keselamatan Pasien:** Total insiden, 2 insiden grading tinggi, status tindak lanjut
- **Analisis:** 1 paragraf singkat penyebab utama
- **Rekomendasi:** 2 rekomendasi spesifik dengan PIC dan tenggat waktu
- **Lampiran:** Notulen rapat dan daftar hadir

Dengan template ini, Komite PMKP cukup mengisi data terbaru setiap periode. Waktu penyusunan laporan bisa dipangkas dari berhari-hari menjadi beberapa jam.

INTI BAB: Laporan evaluasi mutu yang efektif ke Direksi harus ringkas, visual, dan selalu diakhiri rekomendasi tindak lanjut yang spesifik—gunakan template baku agar tidak terlambat dan konsisten setiap periode.

B A B 9

Menyiapkan Bukti Telusur untuk Visitasi Akreditasi

Setelah Anda menyusun program kerja tahunan, indikator mutu, form pelaporan insiden, dan laporan evaluasi di bab-bab sebelumnya, langkah terakhir adalah memastikan semua bukti siap ditelusuri surveior. Surveior akreditasi tidak hanya membaca dokumen, tetapi menelusuri alur logis: dari rapat ke rencana tindak lanjut, dari insiden ke analisis penyebab, hingga bukti perbaikan. Jika dokumen tidak rapi atau tidak saling terhubung, nilai akreditasi bisa jeblok meskipun secara substansi program sudah berjalan.

Dokumen yang wajib disiapkan dalam binder telusur PMKP:

1. SK pembentukan Komite PMKP beserta uraian tugas dan jadwal rapat rutin.
2. Program kerja tahunan PMKP yang sudah disahkan Direktur.
3. Daftar indikator mutu klinis dan manajerial, lengkap dengan profil indikator (definisi, formula, target, sumber data).
4. Data capaian indikator bulanan atau trimester, disertai analisis tren dan rekomendasi tindak lanjut.
5. Form pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP) yang terisi lengkap, termasuk grading risiko.
6. Register insiden dan matriks grading risiko yang dipakai sebagai acuan.
7. Laporan evaluasi mutu berkala ke Direksi dan Komite Mutu RS.
8. Notulen rapat PMKP beserta daftar hadir dan keputusan tindak lanjut.
9. Bukti tindak lanjut insiden dan rencana perbaikan (CAPA) yang sudah

diimplementasikan.

10. Kebijakan, SPO, dan pedoman terkait mutu dan keselamatan pasien yang menjadi rujukan.

Cara mengarsipkan agar siap diperiksa:

- Pisahkan dokumen per kategori: rapat, indikator, insiden, tindak lanjut, dan kebijakan.
- Gunakan binder fisik atau folder digital dengan penamaan jelas, contoh: `PMKP_2026_Rapat_Januari` atau `PMKP_2026_Indikator_Area_Klinis`.
- Urutkan dokumen secara kronologis, bukan acak, agar surveior mudah mengikuti alur waktu.
- Buat daftar isi di bagian depan setiap binder/folder dan update setiap kali ada dokumen baru.
- Simpan dokumen asli di satu tempat khusus, dan siapkan salinan untuk surveior jika diminta.

> ✅ **Checklist: Pastikan semua berkas berikut ada dan saling terhubung sebelum hari-H visitasi: (1) program kerja yang disahkan; (2) daftar indikator + capaian terbaru; (3) minimal 3 form IKP lengkap dengan grading; (4) notulen rapat 6 bulan terakhir dengan bukti tindak lanjut; (5) laporan evaluasi mutu ke Direksi; (6) kebijakan mutu yang masih berlaku.**

Langkah praktis 2 minggu sebelum visitasi:

1. Bentuk tim kecil yang bertugas mengaudit kelengkapan dokumen. Gunakan checklist di atas sebagai panduan.

2. Lakukan simulasi telusur: minta satu orang berperan sebagai surveior yang meminta bukti “rapat bulan Maret” atau “tindak lanjut insiden jatuh”. Catat berapa lama dokumen ditemukan dan apakah alurnya nyambung.
3. Perbaiki gap yang ditemukan, misalnya notulen yang tidak lengkap atau data indikator yang belum diupdate.
4. Siapkan ringkasan eksekutif satu halaman untuk surveior: capaian indikator utama, jumlah insiden per kategori, dan perbaikan kunci periode berjalan.

> **Tips: Jangan hanya menumpuk dokumen di meja. Kelompokkan berdasarkan bab standar akreditasi PMKP, lalu tempel label warna pada binder: hijau untuk rapat, biru untuk indikator, merah untuk insiden, kuning untuk tindak lanjut. Surveior akan lebih mudah menelusuri dan kesan kerapian langsung terlihat.**

Dengan arsip yang tertata dan alur telusur yang logis, Anda tidak perlu panik saat surveior meminta bukti apa pun. Semua sudah dalam genggaman, dan nilai akreditasi bisa dipertahankan tanpa drama.

INTI BAB: Bukti telusur akreditasi harus tersusun rapi, saling terhubung, dan mudah ditemukan dalam hitungan menit. Siapkan daftar dokumen wajib, arsipkan per kategori, lakukan audit internal, dan simulasikan alur telusur surveior sebelum visitasi.